

基礎研 レター

「社会保障負担率の目標」に 向けた険しい道のり

経済財政諮問会議が引下げ目標の検討を提案

経済研究部 主任研究員 野村 彰宏

(03)3512-1838 a-nomura@nli-research.co.jp

<要旨>

- 経済財政諮問会議の民間議員が「社会保障負担率の目標」について検討するよう提案した。本稿では、これまでの社会保障負担（社会保険料）の動向、社会保障負担率とはどのような指標なのか、同負担率を引き下げるにはどうすれば良いかを考える。
- 社会保障負担率は、分母が国民所得であり、保険料率の変動だけでなく、企業の利益や海外からの所得によっても変動するため、家計の負担を測る指標としては分かりにくい面もある。
- 民間議員からは、社会保障改革の様々な提案も行われた。改革事項を総動員しなければ社会保障負担率を大きく引き下げることは難しい。例えば、高齢者の自己負担割合を70-74歳で3割、75-79歳で原則2割に引き上げても、被用者保険における現役世代の保険料率で▲0.2%pt程度、目標となる社会保障負担率で▲0.1%pt程度の引下げ幅にとどまると試算される。

1——政府が社会保障負担率の目標を検討へ

2026年5月22日に経済財政諮問会議が開催され、「成長力強化」と「社会保障」が議題となった。1つ目の議題の成長力強化における「予算編成改革」についての民間議員提案は別稿¹で考察したが、本稿では2つ目の議題の社会保障についての民間議員の改革提案を取り上げる。

社会保障改革についての民間議員ペーパーでは、「マクロ的な社会保障負担率の目標について検討」との提案が行われ、高市首相から関係大臣にそのまま検討の指示が下った。会議の議事要旨も併せて見ると、今よりも社会保障負担率を引き下げることを目標として検討するようである。

また、これと併せて、高市首相からは民間議員の提案も踏まえ、「真に公平な応能負担を実現する医療費窓口負担の見直しや、年齢にかかわらず働き続けることができる社会を実現するための高齢者の

¹ 基礎研レター「経済財政諮問会議が主導する予算編成改革」（2026年5月28日）。

<https://www.nli-research.co.jp/report/detail/id=85674?site=nli>

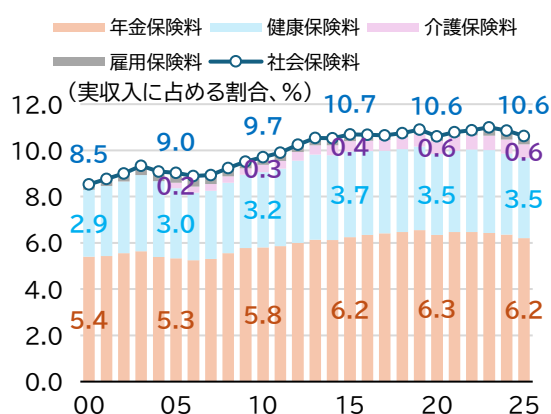
定義の見直しといった、具体的な給付と負担の見直しの検討、それら改革項目の今年度中の具体化と工程の明確化」に取り組むとの指示もなされた。本稿では、これまでの社会保障負担（社会保険料）の動向を振り返り、その上で、社会保障負担率とはどのような指標なのか、同負担率を政策的に引き下げるにはどうすれば良いかを考えたい。

2——社会保障負担は2000年代半ば頃から2010年代後半にかけて増加し、その後は概ね横ばい

社会保障負担というのは社会保険料のことである。政府の社会保障制度で、公的年金の給付、医療・介護サービスの窓口負担以外の給付費用、失業給付などを賄うため、賃金・所得等に応じて徴収される公的な保険料である。2026年4月に導入された子ども・子育て支援金は医療保険料と合わせて徴収される。主にサラリーマンが加入している被用者保険の場合、保険料率は合計すると30%程度になるが、労使折半があるため本人の負担は15%程度になる²。

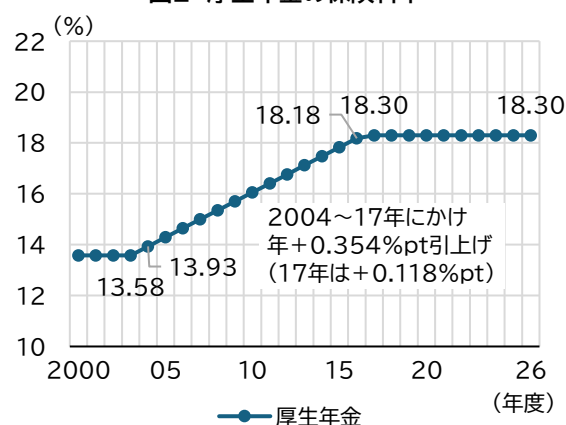
保険料率は、2000年代半ば頃から2010年代後半にかけて引き上げられて、その期間に家計収入に占める保険料負担の割合も上昇した（図1）。負担割合の上昇幅が最も大きかったのは年金である。年金の保険料率は、2004～17年にかけて概ね毎年+0.354%ptずつ計+4.72%pt、現在の18.3%まで引き上げられた（図2）。労使折半なので家計が支払う分の保険料率はその半分になる。次に家計の負担割合への影響が大きかったのは医療で（図3）、協会けんぽは2010～12年度にかけて労使計+1.8%pt引き上げられ、組合健保も2000年代半ば頃から2010年代後半にかけて徐々に+2%pt程度引き上げられた。介護については（前掲図3）、全体の中での割合は大きくないが、徐々に着実に増加してきた。サラリーマンの場合は保険料率にして+3%pt台半ばの本人負担の上昇があったと言える。ただ、年金・医療・介護いずれの保険料率も、2010年代後半から足元にかけては概ね横ばいの推移をしている。

図1 社会保険料の負担割合（勤労者世帯）



（備考）総務省「家計調査」により作成。二人以上世帯のうち勤労者世帯。

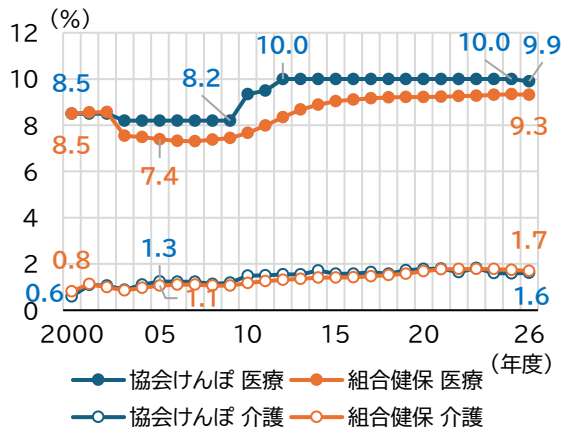
図2 厚生年金の保険料率



（備考）厚生労働省の資料により作成。労使計。

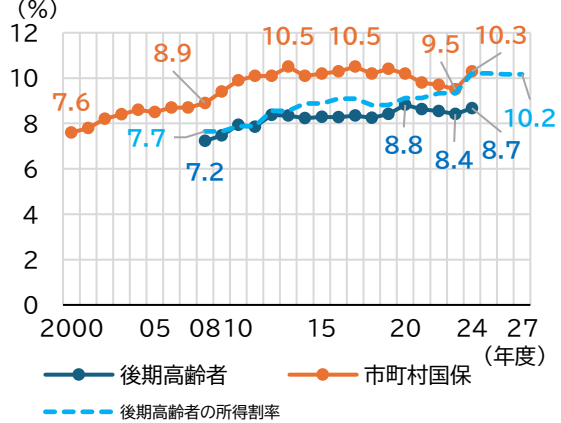
² 例えば、主にサラリーマンが加入する被用者保険の場合、2026年度は、厚生年金18.30%、協会けんぽ11.75%（医療分の全国平均9.90%、40歳～64歳の場合は介護分（全国一律）1.62%、子ども・子育て支援金（全国一律）0.23%）、雇用保険1.35%で合計31.4%となり、うち労働者負担は約15.5%となる（雇用保険は労働者負担が0.5%で、それ以外は労使折半）。

図3 被用者保険(医療・介護)の保険料率



(備考) 全国健康保険協会、健康保険組合連合会の資料により作成。労使計。

図4 国保・後期高齢者の保険料負担割合



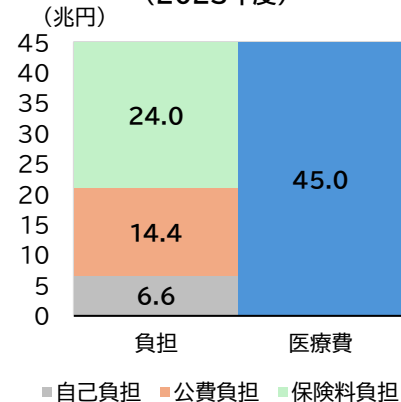
(備考) 厚生労働省「国民健康保険実態調査」、「後期高齢者医療制度被保険者実態調査」により作成。

被用者保険以外については、自営業者やパート労働者等が加入する国保（国民健康保険）や、75歳以上が加入する後期高齢者医療制度は、単純に所得に保険料率を掛けるだけでなく、定額部分や、国保は自治体によっては固定資産税額に応じ徴収される部分もある。そこで、加入者全体について保険料の徴収額を前年所得で割った保険料負担割合について見ると（図4）、国保も後期高齢者も2010年代前半までにかけて上昇した。その後は均してみれば概ね横ばいの範囲内である。

このように、家計の保険料負担は、概ね2000年代半ば頃から2010年代後半にかけて各種の保険料率等が引き上げられたことに伴い上昇し、その後は横ばいで推移している。引上げが行われてきた背景については、特に医療・介護における事情と、年金における事情は少し異なっている。

医療・介護と年金の保険料率の決めり方の違いは、給付と負担をバランスさせるに当たっての視野の長さの違いである。医療・介護は、毎年度に（介護は3年サイクルの中で）発生する医療費・介護費に対し、保険料負担、公費負担（租税、公債）、サービス利用者の自己負担（窓口負担）の3つを合わせてバランスするように決まっている。3つの財源は給付に対する割合が制度的に決まっていて、詳細はかなり複雑だが、医療保険だと結果的には全体の半分強が保険料になっている（図5）。高齢化の進行で病院を受診したり処方薬を利用したりする人が増えると医療費は増える。保険料の主な支え手の現役世代の人数には少子高齢化で下押し圧力もかかる中、保険料収入を確保するために保険料率も上昇することになる³。介護についても構造は同様である。

図5 医療費の負担構造（2023年度）



(備考) 厚生労働省「医療保険に関する基礎資料」により作成。保険制度に基づく部分。

³ 保険料率は国が統一的に定めているわけではなく、各種の制度間財政調整や公費支援はあるものの、その下で各保険者が給付と負担の収支を合わせるように決める。例えば、市町村国保の保険者は市町村である。国保は2015年の法改正により2018年度から都道府県が財政運営の責任主体となるよう広域化されており、都道府県は「標準保険料率」を「理論値」として市町村に提示するようになったが、実際の保険料率はなお個々の市町村が決定している。

他方、厚生年金の保険料率は現在、定率 18.3%に固定されている。国民年金は料率一定ではなく定額（2026 年度 17,920 円／月）だが、名目賃金上昇率に合わせて改定される仕組みになっており、マクロ的に見ると労働所得に対し一定割合で固定する考え方に近い。年金はこのように広い意味では「保険料率」を固定しておいて、医療・介護とは逆に、給付額の方を自動で調整していく仕組みになっている。調整に当たっては、今後 100 年間にわたる超長期の人口動態（少子高齢化の動向や外国人の流入など）、生産性向上や労働参加進展を含む経済成長や物価・賃金の動向等について一定の想定を置いた上で、厚生労働省が試算（財政検証）を行う。給付に対する財源として、「定率」の保険料収入に加え、国庫負担、年金の積立金の運用・取崩も勘案して、少なくとも 100 年後までの給付ができるように給付額を一定の期間、徐々に削減する仕組みになっている（マクロ経済スライドと呼ぶ）。2004 年の抜本的な制度改正により、財政検証に基づき、保険料率は 18.3%まで引き上げた上で固定し、給付調整を行っていくことになったのである。財政検証は 5 年ごとに行われるが、仮に試算上の将来見通しが変わった場合も、多少のことであれば給付削減期間の延長により対応することになっている。

3——社会保障負担率の分母は国民所得であり、目標としての解釈には留意も必要

社会保障負担率は、社会保障負担を分子として、分母は国民所得（NI、要素費用表示）で割って算出される（図 6）。国民所得は GDP に近い概念で、主に雇用者報酬（賃金など）、営業余剰（企業の営業利益など）、海外からの所得（利子・配当など）の 3 種類の所得から成る。保険料は上述したように賃金（標準報酬月額）や前年所得に保険料率を掛けて算出される部分が多く、期ずれなどはあるが基本的に雇用者報酬が増えれば保険料も増える。

社会保障負担率は、上述した 2000 年代半ば頃から 2010 年代後半の保険料率の引上げに沿って上昇してきた（図 7）。それ以降の 2020 年度前後からの変動については、分母の国民所得の変動によって引き起こされている（図 8）。

図 6 社会保障負担率の定義等

$$\text{社会保障負担率} = \frac{\text{保険料}}{\text{国民所得}} = \frac{\text{保険料}}{\text{雇用者報酬} + \text{営業余剰} + \text{海外所得}}$$

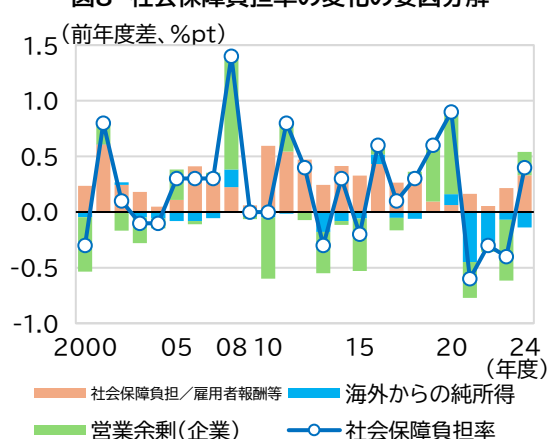
雇用者報酬が増えれば保険料も増える

（備考）内閣府資料により作成。国民所得は正確には家計の混合所得（持ち家を除く個人企業の取り分）も含む。

図 7 社会保障負担率



図 8 社会保障負担率の変化の要因分解



（備考）財務省「国民負担率（対国民所得比）の推移」、内閣府「国民経済計算」により作成。図 8 の「雇用者報酬等」は、雇用者報酬に家計の営業余剰・混合所得を足したものの。「営業余剰（企業）」は非金融法人企業と金融機関の営業余剰を足したものの。

2019、20 年度は、世界経済の減速やコロナ禍で企業の利益が大幅に減少し、分母の国民所得が減少したことで社会保障負担率が上昇した。その後は、コロナ禍からの回復過程で、企業の利益が回復したことや、海外からの所得が大幅に増加したことで国民所得が増加し、社会保障負担率が低下した。海外からの所得の増加は、主に株の配当、直接投資に関する再投資収益（企業の現地子会社が上げた利益のうち、日本国内に配当などで還流されず現地の内部留保となった部分）、利子の受取である。

このように、国民所得を分母とする社会保障負担率を政策目標とする場合、企業の利益や、海外からの所得の変動が攪乱要因になる点で分かりにくさがある。また、次のような別の分かりにくさもある。分母の国民所得はGDPと似たような概念であるから、「経済成長することで社会保障負担率を引き下げる」ことが可能かどうかを考えてみよう。経済が成長し、それに合わせて賃金が増えても、保険料率が一定であれば賃金の伸びと同じ率だけ保険料が増え、基本的に負担率は変わらない⁴。この時、もし経済成長により企業利益も増えることで負担率が低下していれば、それは企業利益の伸びが賃金の伸びを上回っているということである。経済成長の果実の配分としては、労働者の取り分（労働分配率）が低下している⁵。社会保障負担率が低下していても、家計負担が低減しているわけではなく、目標は達成していても政策の目的・趣旨は達成されていない。

海外からの所得についても、個人に海外の株や債券への投資を促して可処分所得を増やすこと自体は所得政策としてはあり得るが、社会保障負担の低減という目的とは直接関係しない。分母は国民所得を使うよりも、雇用者報酬などにした方が分かりやすい指標になるのではないと思われる。少なくとも解釈には留意が必要である。

なお、前掲図8に戻ると、社会保障負担の寄与から雇用者報酬等（自営業者等の所得を含めている）の寄与を引いたものが、上述のように被用者保険の保険料率は近年概ね横ばいにもかかわらず、2023、24 年度とプラスに出ている。2024 年度については、前掲図4 で見たように国保や後期高齢者医療制度の負担割合が上昇している。後期高齢者については、保険料率が大きく引き上げられており、激変緩和措置はあったものの、加入者全体で見た保険料負担割合も上昇している⁶。国保については、2024 年度に急上昇しているが、この年は大きな制度改正は行われていない⁷。保険料は市町村ごとに決まり、詳細は不明だが、統計を見ると、2024 年度は世帯当たりの前年所得が大きく減少する一方、保険料徴収額が大幅に増えている。サンプル調査ではあることから、統計上の振れの可能性もあり得る。

⁴ 標準報酬月額の上限等級の額は頻繁に改正されるわけではないため、賃金が増え上限等級を超えると保険料負担割合が下がることはある。上限等級の額は、健康保険（協会けんぽや健保組合等）については2016年4月に121万円から現在の139万円に引き上げられた。厚生年金については2020年9月に62万円から現在の65万円に引き上げられた後、2025年の法改正により、2027年9月から2029年9月にかけて3段階で75万円まで引き上げられることとなっている。

⁵ 逆に、営業余剰と海外所得の伸びが雇用者報酬の伸びより低いと、労働分配率が上がるが、社会保障負担率も上がる。

⁶ 後期高齢者医療制度の財源には現役世代の保険料から支援金が投入されているが、現役世代の1人当たり支援金の伸びは後期高齢者の1人当たり保険料の伸びを大幅に上回る状況となっていた。現役世代の負担抑制のため、伸びを同じにする法改正が2023年に行われ、後期高齢者の保険料率は2024年度に大幅に引き上げられた。ただし、6割の後期高齢者には負担増が生じないようにするなど激変緩和措置が取られ、加入者平均で見た負担割合の上昇幅は料率に比べると抑制的になった。

⁷ 例えば、国保保険料の年間の賦課限度額は2024年度に104万円から106万円に+2万円引き上げられたが、給与収入で約1160万円以上の高所得者が対象になるものであり、対象世帯数の割合は1%強だった。同時に中間所得層では保険料額が引き下げられている。この年以前も、2022年度は+3万円、2023年度は+2万円と累次にわたり行われている措置である。

4——社会保障負担率を低下させるには改革の総動員が必要

次に、政策的にどうすれば社会保障負担率を引き下げられるのか、民間議員ペーパーの提案を参照しつつ考えてみたい。同負担率を引き下げするための手段は様々考えられるが、上述したように「経済成長で分母の増加により負担率を引き下げる」というのは、家計負担の低減に必ずしもつながらない。従って、分子の社会保障負担、特に医療・介護の保険料率を引き下げていくことが必要になる。

なお、年金は上述のとおり保険料率の決まり方が異なることもあり、本稿では議論を割愛する。

（医療・介護費の削減）

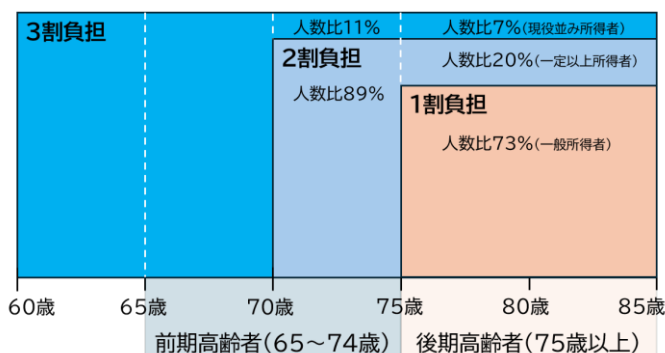
社会保障負担率の引下げのために、まず考えられることは医療費・介護費を削減することである。上述のように医療・介護の保険料負担（及び税・自己負担の総額）は費用と概ねバランスするようになっているので（前掲図5）、医療費・介護費の全体を削減できれば保険料も連動して下がる。ただ、医療・介護費の増加圧力は強い。高齢化の進行により、医療・介護サービスを受給する人の数全体が増え、高齢者の中でもより年齢の高い人の割合が多くなる結果1人当たりの医療・介護費用も増加する。近年のインフレで物件費も人件費も増加しているが、特に介護人材は人手不足であるのに賃金水準は他産業の労働者の平均より低く、サービス提供体制の維持のためには更なる賃上げが必要である。医療の高度化で薬剤・医療機器などが高額化する影響もある。医療・介護費用は、増加を抑制し、現状程度に維持するだけでも相当の努力が必要になる。それを更に削減するとなれば、様々な施策を総動員しなければ達成は難しい。前掲図1～4で見たように2010年代後半以降に保険料率や負担割合が上昇していないのは、そうした様々な政策努力の効果でもある。諮問会議の民間議員ペーパーでも、病床の適正化、医療機関の集約化、リフィル・長期処方 の活用推進、A I 活用、攻めの予防医療など様々な政策提言がなされており、これらを着実に進めていく必要がある。

（自己負担割合の見直し①：応能負担）

次に考えられるのは負担の構造を変えることである。民間議員ペーパーでは、「給付と負担の一体的な改革」として、①年齢によらない真に公平な応能負担を実現する医療費窓口負担の見直し、②介護の利用者負担の見直し、③「高齢者」の定義の見直し、④軽微で日常的に利用する医薬品・医療（低いリスク）に対する必要な方策、を検討すべきとしている。これらは前掲図5の「自己負担」の部分を引き上げるものである。

高齢者の医療費について言えば、現在、70歳未満の人は医療費の3割を窓口で自身の負担により支払っているが、70～74歳は原則2割負担で、75歳以上になると原則1割負担になる（図9）。「原則」というのは、一定基準以上の収入があれば自己負担率が上がるためだが、その基準は高く設定されて

図9 高齢者の年齢区分と自己負担割合



（備考）厚生労働省の社会保障審議会・医療保険部会（2025年12月4日）の資料等により作成。

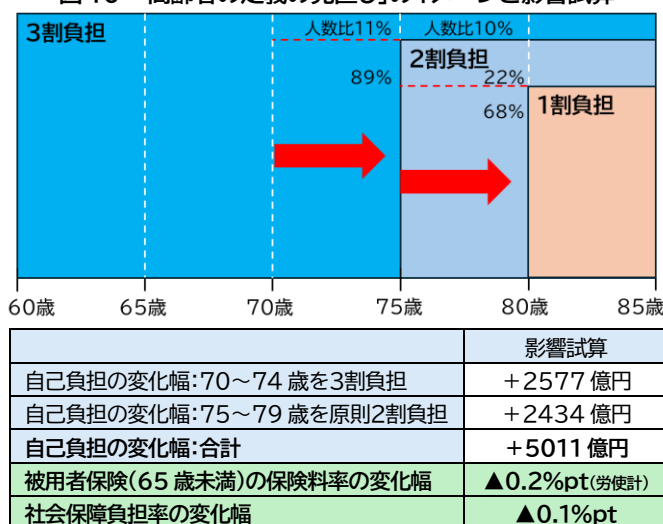
おり⁸、原則より多く負担している人は少ない。ここ 20 年程で、年齢を重ねても元気に過ごしている高齢者が増え、労働参加も進んでいることから、この収入基準を見直すなどすれば、自己負担の総額は増え、それによって保険料率を引き下げることにも可能になる。これが民間議員ペーパーにおける上記①の論点である。収入以外に、資産などの情報も把握して要件に入れるなど、負担できる能力のある高齢者には応分の負担をしてもらい、現役世代の負担を下げるのが意図されている。こうした改革は徐々に進められてきており、今は後期高齢者にも 2 割負担が導入されているが、これは 2021 年の法改正により、2022 年 10 月から施行された。

（自己負担割合の見直し②：高齢者の定義）

また、高齢者の中での所得の高低に着目する以外に、元気な高齢者が増えている中で、2 割負担、1 割負担になる「高齢者」の定義そのものを現行の 70 歳や 75 歳から見直すべきではないか、というのが民間議員ペーパーにおける上記③の論点である。例えば、3 割負担を 74 歳、原則 2 割負担を 79 歳まで引き上げる（図 10）⁹。この場合、自己負担の総額が 70～74 歳は 6110 億円、75～79 歳は 5082 億円（2023 年度）であることを基に、負担割合により医療費が変わらないと仮定した上で、各負担割合の人数比から単純計算すると、+5000 億円程度の自己負担引上げに相当する。この額を、仮に被用者保険（協会けんぽ、組合健保、共済など）の現役世代（65 歳未満）の保険料率の引下げに全額当てたとすると、労使計で今よりも▲0.2%pt 程度の引下げが可能と試算される。労働者負担分に限ると▲0.1%pt である。目標である社会保障負担率についても、▲0.1%pt の引下げにとどまる。

ここでの数値例はかなり単純化した設定であり、実際には低所得など負担能力の低い高齢者への配慮も必要になることを考えると、自己負担総額の増加幅はより小さくなると考えられる¹⁰。かなり大胆な改革を行っても、社会保障負担率の引下げはハードルの高い目標であることが分かる。社会保障負担率を目標に据えるに当たっては、様々な改革を総動員して進めていくことが求められる。

図 10 「高齢者の定義の見直し」のイメージと影響試算



（備考）厚生労働省「医療保険に関する基礎資料」、「後期高齢者医療事業年報」、内閣府「政府経済見通し」により作成。人数比は 2023 年度（75-79 歳は 2023 年度末）。社会保障負担率の変化幅を計算するに当たり、分母の国民所得は政府経済見通しにおける 2026 年度の値とした。

⁸ 例えば、3 割負担の対象となる現役並み所得の判定基準は、①世帯内に「課税所得」145 万円以上の被保険者がいること、かつ、②世帯の被保険者全員の「収入」の合計額が 520 万円以上（世帯の被保険者が 1 人なら 383 万円以上）であることとなっている。②の要件は、①の要件を起点にして、基礎控除、給与所得控除、配偶者控除、社会保険料控除、公的年金等控除を積み上げて算出されたもので、後期高齢者はこれを超えない限りは 2 割又は 1 割負担となる。

⁹ 財務省の財政制度等審議会・財政制度分科会への提出資料（2026 年 4 月 28 日）では「原則 3 割負担化」が目指されている。

¹⁰ 自己負担には高額療養費制度による上限が設けられていることから、実際の影響額はこの試算より小さくなり得る。一方、自己負担割合の引上げで、疾病が軽度な場合などに受診抑制につながることも考えられ、その場合には負担の構成変化だけでなく医療費も減少し、保険料負担の減少幅が大きくなることもあり得る。